

ECCEMA

Samsan

INTRODUCCIÓN

El término eccema hace referencia a un patrón clínicopatológico de inflamación cutánea debido a múltiples causas, siendo la espongiosis la lesión histológica más característica.



DIAGNÓSTICO

El diagnóstico del eccema se basa en las manifestaciones clínicas características como son: el prurito que puede ser de intensidad variable y las lesiones eritematosas en la piel.

En función del tiempo de evolución, se distinguen tres fases sucesivas:

Eccema agudo: Comienza como un eritema y edema localizado en forma de máculas o pápulas con vesículas que suelen ser pequeñas y agrupadas. La rotura de éstas da lugar a un exudado que termina en la formación de una costra.

Eccema subagudo: Predominan las lesiones descamativas.

Eccema crónico: Liquefificación con engrosamiento de la piel, grietas, fisuras, alteraciones en la pigmentación y lesiones de rascado.

Debemos indagar en la anamnesis en los antecedentes personales y familiares del paciente, el tiempo de evolución y la extensión de las lesiones, las regiones afectadas, los antecedentes epidemiológicos (trabajo, deportes, mascotas, plantas) y en los tratamientos realizados previamente y su resultado en el caso de que los hubiese realizado.

Actualmente, se suelen clasificar los eccemas en base a su etiología:

Dermatitis numular: Afecta sobre todo a adultos de ambos sexos entre los 50-70 años y en meses invernales. Se trata de lesiones localizadas, con placas eritematodescamativas redondeadas afectando habitualmente en las piernas y brazos.

Dishidrosis: Aparece en personas con lavados frecuentes de manos. Consiste en vesículas y/o descamación en caras laterales de los dedos de manos y pies, muy pruriginosas.

Dermatitis atópica: Es una enfermedad inflamatoria y pruriginosa de la piel. Suele presentarse con mayor frecuencia en la población infantil aunque no es exclusiva. A menudo hay un aumento sérico de inmunoglobulina IgE y suele asociarse unos antecedentes personales y familiares de atopia. En la edad adulta las lesiones predominan a nivel labial, periocular y perioral, cuello,

flexuras y dorso de las manos. Suelen presentar xerosis, manchas descamadas eritematosas, pequeñas vesículas, excoriación, costras y, no infrecuentemente, impetiginización. El diagnóstico se basa en la clínica: picor, distribución típica según la edad, curso en brotes e historia familiar (asma, rinitis, alergias)

Dermatitis seborreica: Manchas eritematosas con escamas finas de aspecto grasiento, habitualmente en región malar, frente, tórax y cuero cabelludo.

Eccema de contacto irritativo y eccema de contacto alérgico: Los agentes irritantes más frecuentes son los ácidos o álcalis fuertes y disolventes utilizados con frecuencia en la industria y por el ama de casa.

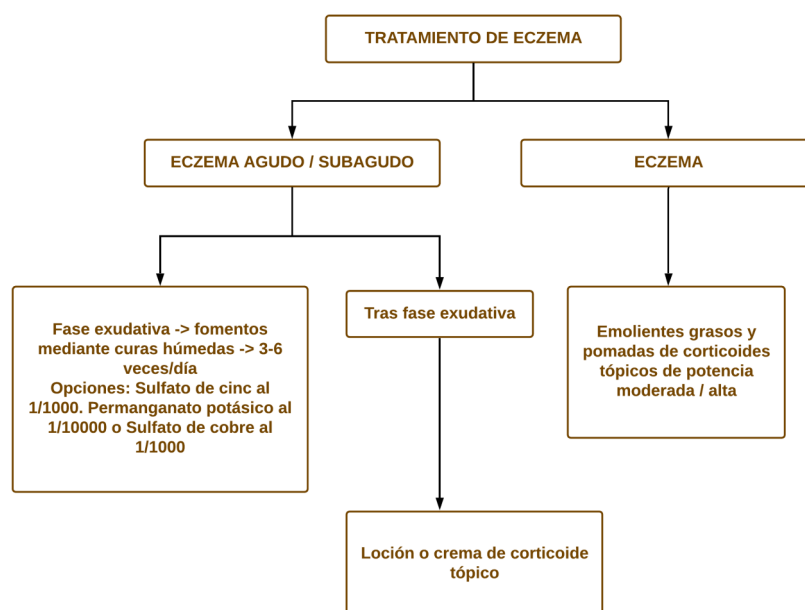
ECCEMA DE CONTACTO IRRITATIVO	ECCEMA DE CONTACTO ALÉRGICO
Mecanismo no inmunológico. Citotóxico directo	Mecanismo inmunológico. Reacción de hipersensibilidad tipo IV
Inicio en minutos/horas	Inicio en horas/días
Localizado sólo en la zona de contacto	Se extiende por la periferia. Puede generalizarse
Bordes bien definidos	Bordes imprecisos
Síntomas asociados: escozor, dolor, quemazón	
Influye el tiempo de contacto y la concentración del irritante	Depende del grado de sensibilización del paciente, con independencia de la concentración del agente
Agua, jabones, disolventes, saliva, orina, ácidos, bases	Metales, cosméticos, fármacos, adhesivos, resinas

TRATAMIENTO EN URGENCIAS

Medidas generales:

- Evitar cambios de temperatura bruscos.
- Evitar el estrés.
- Ducha diaria corta con agua fría. Jabón pH neutro. Secar con suavidad sin frotar.
- Usar ropa amplia y de algodón. Evitar la lana, eliminar etiquetas o costuras, utilizar detergentes suaves y evitar suavizantes.
- Aplicar diariamente crema hidratante tras la ducha y siempre que sea necesario. No usar durante el brote agudo ya que pueden empeorar el cuadro.
- Realizar un buen control del prurito: cortar bien las uñas, hidratación
- Evitar alimentos sólo si existe relación directa con los brotes (demostración clínica y analítica).

Tratamiento específico:



Tratamiento sistémico: En los casos más graves y extensos, pueden utilizarse corticoides sistémicos (Prednisona a 0,5-1mg/Kg/día). Para aliviar el prurito se emplearán antihistámicos por vía oral, está contraindicada la vía tópica. Puede estar también indicado el uso de ansiolíticos para disminuir la ansiedad y favorecer el sueño en algún paciente adulto. En el caso de que sospechamos sobreinfección bacteriana habría que iniciar tratamiento con antibióticos que cubran tanto al *S. aureus* como el *Estreptococo* betahemolítico del grupo A tales como Cloxacilina o Amoxicilina-clavulanico.

Criterios de derivación a Dermatología son: lesiones generalizadas, no respuesta a la terapia tópica, sobreinfecciones graves o dudas diagnósticas.

BIBLIOGRAFÍA

- Lera Imbuluzqueta JM, Bernad Alonso I, Ivars Lleó M, España Alonso A. Dermatitis de contacto. *Medicine*. 2014 ;11(48): 2813-22.
- Infante Hernando ML, Serra Baldrich E. Tratamiento del eccema de manos. *Mas Dermatol*. 2012; 17: 22-25.
- Goldman-Cecil. Tratado de medicina interna. Eccemas, fotodermatosis, enfermedades papuloescamosas (incluidas las fúngicas) y eritemas figurados. 25ª Edición. Elsevier. 2016. 2662-2671.
- Ferrándiz C. Dermatología Clínica. Eccemas. Elsevier. 2014. 91-97.
- Senán Sanz MR, Casanova Seuma JM Dermatólogo. Eccemas. *AMF* 2012; 8:185-196.
- Garavís González JL, Ledesma Matín MC, de Unamuno Pçerez P. Eccemas. *Semergen* 2005; 31: 67-85.

LIQUEN PLANO

María Jesús Suarez valladares

- El liquen plano es un trastorno autoinmunitario poco frecuente de causa desconocida.
- Se identifican las 5 P: pequeñas placas o pápulas brillantes, poligonales, pruriginosas, de color violáceo-púrpura. Son características unas líneas blancas superficiales denominadas estrías de Wickham.
- Suelen aparecer en muñecas y tobillos. Existen otros patrones que afectan a mucosas o al cuero cabelludo.
- Cursa en brotes y puede tener una resolución espontánea. Lo más habitual es el manejo con corticoides tópicos.

INTRODUCCION

El liquen plano es una enfermedad inflamatoria crónica, poco frecuente, que ocupa el 1% de las consultas dermatológicas. Lo más frecuente es su presentación en la piel, aunque puede afectar también a mucosas (oral o genital).

El origen de la enfermedad radica en una alteración inmunológica donde los linfocitos T atacan a las células de la epidermis provocando esas lesiones inflamatorias. Parece que los brotes pueden estar relacionados con episodios de estrés o ansiedad, algunos fármacos o la infección por una hepatitis C.

DIAGNOSTICO

Las manifestaciones del liquen plano son bastante típicas por lo que, con un examen cutáneo adecuado y un interrogatorio completo no debería ser necesario llegar a una biopsia que confirme el diagnóstico.

El cuadro típico es un paciente que de forma repentina desarrollan papulas y placas poligonales de pequeño tamaño, de un característico color violáceo o purpúrico, muy pruriginosas. Es muy característico la aparición de unas pequeñas líneas blancas superficiales en forma de red, conocidas como estrías de Wickham. Suelen afectar a la cara interior de las muñecas, tobillos o parte inferior de la espalda, aunque de forma progresiva se pueden generalizar al tronco y resto de extremidades. (Figura 1)

Hasta en un 50% de las veces pueden tener una afectación de mucosas a nivel lingual, boca y genital. Cuando las lesiones aparecen en mucosa oral se observan unas líneas blanquecinas, eritematosas o erosivas que pueden ocasionar molestias a la hora de ingerir alimentos y que en un porcentaje muy bajo podrían tornar a una lesión maligna. (Figura 2)

Cuando la inflamación causada por el liquen afecta a los folículos pilosos, podemos observar una alopecia parcial o total en la zona con discreto eritema perifolicular y punteado de queratosis característico. Generalmente la pérdida de cabello es irreversible. También, hasta en un 15% de los pacientes existe afectación ungueal que suele provocar la atrofia de la uña (Figura 2).

Otros patrones podrían ser el liquen plano anular, atrófico, hipertrófico, ampollar, pigmentoso, actínico o ungueal.

Cuando se confirma el diagnóstico es recomendable descartar una posible asociación a

infecciones víricas (mediante serologías), toma de fármacos o clínica.



Figura 1. Localización típica de lesiones por liquen en muñecas y tobillos. En la última fotografía se puede apreciar con más detalle las típicas papulas planas poligonales de color violáceo.



Figura 2. Otras localizaciones menos frecuentes pueden ser la mucosa oral, donde se aprecia el típico reticulado blanquecino. Cuando el liquen afecta a las uñas se observa un adelgazamiento y fragilidad ungueal (onicorrexis) y un despegamiento distal (onicoquisis).

TRATAMIENTO EN URGENCIAS

El tratamiento dependerá de la extensión y sintomatología causada. En muchas ocasiones como ya hemos destacado, cursa en brotes con una duración autolimitada.

En las formas localizadas, que son las más frecuentes, se puede controlar con corticoides tópicos potentes en crema o emulsión dependiendo de la extensión, la posología adecuada sería aplicar 2 veces al día hasta resolución de lesiones y prurito y posteriormente 1 vez al día durante una semana más para disminuir el riesgo de recidiva. También es posible combinar éstos con derivados de la vitamina A (tretinoína) tópicos para ahorrar el uso de los corticoides, especialmente cuando las lesiones presentan una hiperqueratosis o escama acusada. Si el paciente presenta mucho prurito se pueden añadir antihistamínicos orales para conseguir un mejor control.

Cuando la enfermedad es más generalizada o no responde al primer escalón de tratamiento, lo más adecuado es derivar a un dermatólogo. En estos casos, se pueden emplear tratamientos

sistémicos como los corticoides orales o retinoides orales. También es útil la fototerapia (rayos UVA) o el metotrexato.

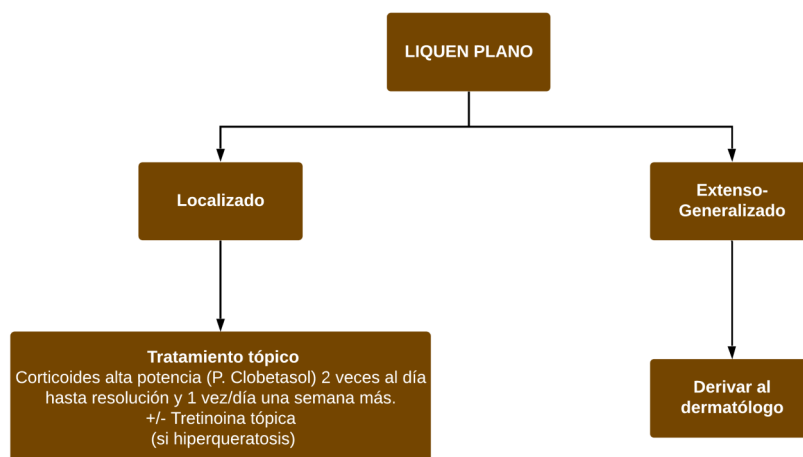


Figura 3. Algoritmo de tratamiento en urgencias de liquen plano según extensión de las lesiones

BIBLIOGRAFIA

- Rodríguez Acar M, Carbajal Pruneda P. Liquen plano. Revisión de la literatura. Rev Cent Dermatol Pascua 2006;15(3):203-208.
- Usatine RP, Tinitigan M. Diagnosis and treatment of lichen planus. Am Fam Physician, 2011;84:53-60.
- Boyd AS, Neldner KH. Lichen planus. J Am Acad Dermatol. 1991;25:593-619.
- Pittelkow M, Daoud MS. Lichen planus. En: Wolff K, Goldsmith L, Katz S, Gilchrest B et al: Fitzpatrick Dermatología en medicina general; 7º edición. España. Editorial Médica Panamericana. 2009. Págs 244-55.
- Kwar AJ De D. Methotrexate for treatment of lichen planus: old drug, new indication. J Eur Acad Dermatol Venereol 2013; 27:e410-13.

DERMATOSIS AMPOLLOSAS

María Jesús Suarez valladares

- La aparición de ampollas o vesículas en un paciente pueden tener múltiples causas, lo más importante es realizar una historia clínica exhaustiva que nos oriente hacia el posible origen de las lesiones.
- Hay que prestar especial importancia a la ingesta de fármacos nuevos, historia de traumatismos o quemaduras, edad del paciente, localización, distribución (piel y/o mucosas) y presencia de síntomas acompañantes.
- Es necesario realizar una biopsia diagnóstica (incluso previo a la instauración de tratamiento) a todas las enfermedades ampollosas para identificarlas y poder tratarlas correctamente.
- Se puede manejar con corticoides tópicos, dejando los tratamientos sistémicos para pacientes con un diagnóstico de certeza o brotes muy extensos.

Datos clínicos	Posible diagnóstico	Manejo
¿Placas con ampolla en periferia? ¿Diseminación rápida? ¿Costra color miel?	Impétigo ampollar	Antibiótico tópico en formas localizadas u oral si extenso
¿vesículas agrupadas en racimo? ¿Mucosa oral o genital/nariz/lumbo-sacra? Recurrencias	Infección VHS (virus herpes simple)	Antivírico sistémico si importante extensión. Tratamiento profilaxis si > 1 brote/mes
¿Dolor? ¿Placa eritemato-edemaosa + vesículas agrupadas? ¿Trayecto metamérico?	Herpes Zoster	Antivírico sistémico (72h iniciales) Sulfato de Zinc. Afectación punta nasal u ojo, derivar OFT
¿Prurito incoercible de predominio nocturno? ¿Afectación convivientes? ¿Excoriaciones por rascado? ¿Vesículas y surcos interdigitales?	Escabiosis	Permetrina 5% (repetir a la semana) Tratamiento convivientes y fómites
¿Fármacos? ¿Exantema inicial? ¿Mal estado general?	Síndrome Stevens-Johnson / Necrosis epidérmica tóxica	Urgencias especialista dermatología +/- UCI.
¿vesículas claras en laterales de dedos o plantas? ¿Prurito intenso? ¿Recidiva de brotes?	Eccema dishidrótico	Corticoide tópico de alta potencia (noches oclusión) Reducir sudoración.
¿Edad avanzada? ¿Fármacos? ¿Neoplasia? ¿Afectación de mucosa oral?	Enfermedades ampollosas autoinmunes (Pénfigo – Penfigoide)	Derivar al dermatólogo

###INTRODUCCION

En la tabla se muestran algunas de las enfermedades cutáneas que cursan con ampollas o vesículas que, más frecuentemente, podemos observar en urgencias.

Una historia clínica bien orientada y un examen físico adecuado van a ser cruciales para identificar el origen de las lesiones y poder plantear un correcto tratamiento.

A continuación hablaremos de las enfermedades ampollosas, que agrupan un conjunto de patologías muy distintas, la mayoría de causa autoinmune, que tienen en común la formación de ampollas. Estas ampollas ocurren por un despegamiento de la epidermis por la formación de anticuerpos contra las proteínas que intervienen en las uniones intercelulares.

DIAGNOSTICO**Enfermedades ampollosas autoinmunes****Pénfigo**

El pénfigo es una enfermedad producida por la formación de unos anticuerpos (IgG) contra las desmogleinas 1 y 3 de la epidermis provocando una formación de ampollas que pueden afectar a mucosa oral y piel.

Son unas ampollas intraepidérmicas flácidas (que se rompen fácilmente) sobre piel sana y típicamente presentan un signo de Nikolsky positivo (despegamiento de la piel sana por fricción).

El diagnóstico es clínico pero precisa una biopsia de confirmación, además de identificar la presencia de anticuerpos anti desmogleina I y III en sangre (los más frecuentes).

La forma más frecuente es el pénfigo vulgar, que suele iniciar con lesiones en mucosas (Figura 1b) y posteriormente extenderse al resto del cuerpo (Figura 1a). Existen otros tipos menos graves como el superficial, el gravídico o el desencadenado por fármacos.

Ante un paciente en urgencias con sospecha de pénfigo, lo más importante es la reposición hidroelectrolítica y evitar la sobreinfección, ya que se trata de pacientes con grandes áreas denudadas. El tratamiento de elección inicial serán los corticoides de alta potencia tópicos en formas localizadas u orales en casos extensos (siempre que sea posible tras la tener una confirmación histológica).

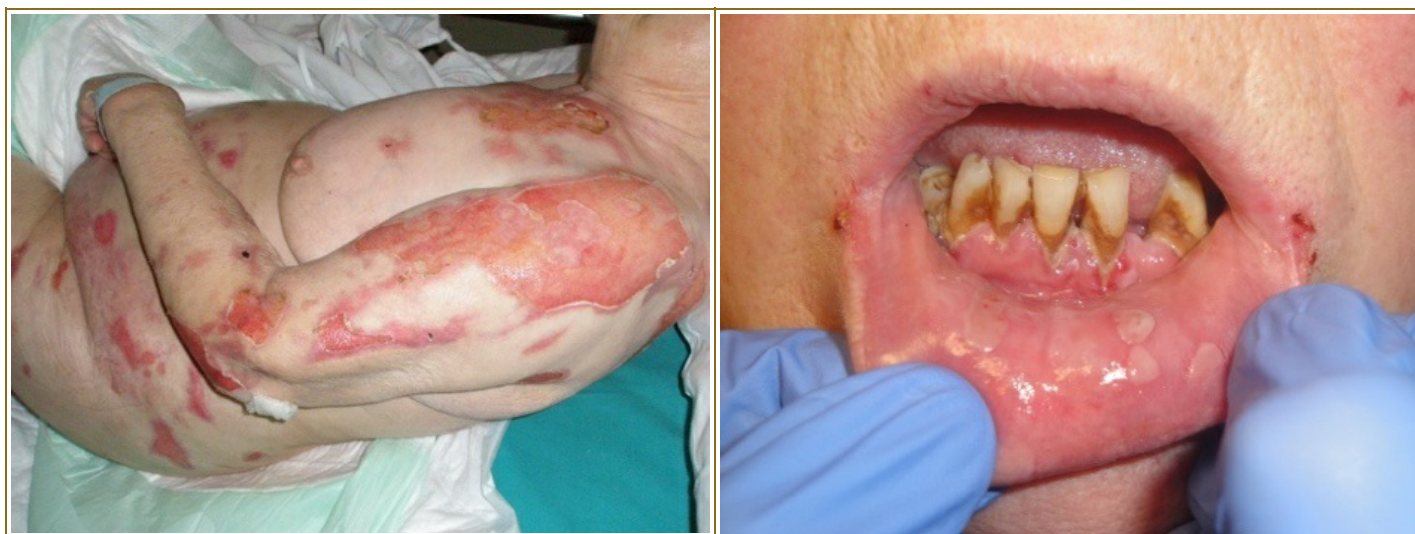


Figura 1a. Áreas denudadas extensas en las extremidades y torax de un paciente con pénfigo vulgar. 1b. Afectación oral del pénfigo con ampollas y áreas denudadas en mucosa.

Penfigoide ampolloso

Se trata de una entidad frecuente en personas mayores, donde hay una producción de anticuerpos anti-bp180 dirigidos contra los hemidesmosomas de la membrana basal epidérmica. Clínicamente los pacientes refieren intenso prurito con la posterior formación de ampollas tensas sobre una piel eritematosa. No tienen signo de Nikolsky y no suele afectar a mucosas. Para su diagnóstico se precisa una biopsia de confirmación con inmunofluorescencia directa para identificar depósitos de IgG y C3 en membrana basal).

Cursa en brotes y suelen responden a los tratamientos tópicos con corticoides de alta potencia.

En ocasiones se pueden asociar antihistamínicos orales para el control del prurito. Su pronóstico es más favorable que el pénfigo.



Figura 2. Ampollas tensas sobre piel sana en extremidad inferior de un paciente con un penfigoide ampollosa. Las lesiones suelen ser muy pruriginosas.

Penfigoide del embarazo o Herpes Gestationis

Es una enfermedad poco frecuente típica de mujeres embarazadas que puede iniciarse como un prurito en las primeras semanas del embarazo para dar paso a unas ampollas de predominio periumbilical y zonas proximales de extremidades. No suele existir afectación mucosa. El cuadro tiende a mejorar las últimas semanas del embarazo y empeorar 3-4 meses después del parto. El cuadro se puede repetir en posteriores embarazos con una presentación precoz y más severa. Para su diagnóstico es importante tomar una biopsia que confirme la presencia de anticuerpos en membrana basal. El manejo durante el embarazo será con corticoides tópicos y antihistamínicos orales, reservando otros fármacos para el periodo del puerperio.

Dermatitis herpetiforme

Es una enfermedad autoinmune frecuentemente asociada a enfermedad celíaca o sensibilidad al gluten. Se caracteriza por lesiones tipo vesícula muy pruriginosas con una distribución simétrica en glúteos, codos, sacro, rodillas... muchas veces solo se aprecian escoriaciones. No suele afectar a mucosas. El tratamiento consiste en realizar una dieta exenta de gluten y sino se controla asociar sulfonas.

Otras enfermedades ampollosas

Virus Herpes

Tanto el herpes simple como el varicela-zóster pueden formar lesiones vesiculosas de diferente distribución según el organismo implicado, además se pueden acompañar de un pródromos e intenso dolor. Se debe de manejar con antivirales orales.

Impétigo Ampollosa

Es una infección causada por el *Staphylococcus Aereus*, que causa unas ampollas flácidas de contenido purulento que rápidamente se rompen dejando erosiones superficiales. Suele afectar a zonas periorificiales y afectar a convivientes. Su tratamiento es con antibióticos orales.

Enfermedad Mano-Pie-Boca

Infección por Coxsackie que típicamente afecta a bebés y niños pequeños con sintomatología general de fiebre, dolor faríngea y lesiones ampollosas en manos y pies.

Traumatismos

Ampollas causadas por quemaduras o por un apoyo prolongado de personas que permanecen

inmóviles durante mucho tiempo, suelen ser la base de las úlceras.

Eccemas

Cuando los eccemas son muy agudos pueden presentar ampollas y/o vesículas con contenido seroso. Aparece típicamente en los eccema dishidróticos

Fitofotodermatosis

Existen algunas plantas (higuera o cítricos) que pueden sensibilizar la piel tras el contacto con ellas, provocando que una exposición solar cause lesiones tipo quemadura con formación de ampollas.

Toxicodermias

Algunas reacciones cutáneas a fármacos pueden provocar ampollas, entre ellas debemos diferenciar el eritema exudativo multiforme, el síndrome de Steven-Johnson y la necrosis epidérmica tóxica. Todos precisan de un diagnóstico y tratamiento precoz para evitar complicaciones con fatal desenlace.

TRATAMIENTO EN URGENCIAS

Recomendaciones prácticas en urgencias ante un paciente con lesiones ampollosas.

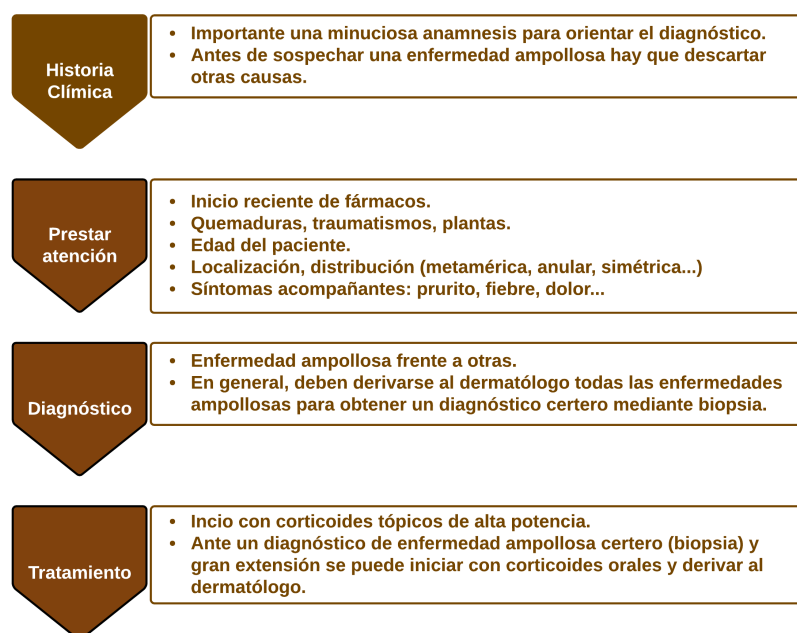


Figura 3. Algoritmo de manejo en urgencias ante un paciente con lesiones ampollosas

BIBLIOGRAFIA

- Kershenovich R, Hodak E, mimouni D. Diagnosis and classification of pemphigus and bullous pemphigoid. Autoimmun Rev. 2014;13:477-81.
- Sánchez-Perez J, García-Diez A. Pénfigo. Actas Dermosifiliogr. 2005;96:329-56.
- Suárez-Fernández R, España-Alonso a, Herrero-González JE, Mascaró-Galy JM. Manejo práctico de las enfermedades ampollosas autoinmnes más frecuentes. Actas Dermosifiliogr. 2008;99:441-55.

ERITEMA MULTIFORME.

Pedro Rodríguez-Jiménez, Pablo Chicharro, Alejandra Reolid

INTRODUCCIÓN

El eritema multiforme (EM) es un síndrome autolimitado agudo, de intensidad leve o moderada y que tiende a la recurrencia en al menos el 30% de pacientes. Aparece en todas las edades, siendo más frecuente en adolescentes y personas jóvenes y raro en niños y ancianos. El síndrome normalmente se relaciona con una infección aguda, siendo en más de la mitad de los casos el culpable el virus del herpes simple (VHS). La segunda causa más frecuente y la primera en casos pediátricos la infección por *M.pneumoniae*. La causa farmacológica es infrecuente y normalmente se tratan de reacciones adversas a medicamentos con una morfología “EM-like”. Por otro lado, hablaremos de EM menor cuando aparecen lesiones cutáneas sin lesiones mucosas y EM mayor cuando estas últimas si están presentes, lo que ocurre en aproximadamente el 70% de pacientes.

DIAGNÓSTICO

El EM se define por sus características clínicas: lesiones en placa con morfología en diana con o sin ampolla central, con un eritema de color vivo o un tinte purpúrico y con un predominio de afectación en cara y región acral de extremidades que aparecen en pocos días. Los pacientes con afectación mucosa presentan erosiones en labios y mucosa oral y afectación de la mucosa ocular, nasal, uretral y anal puede ocurrir. Un tercio de pacientes presenta fiebre franca en el momento del brote de las lesiones y estos pacientes suelen asociar linfadenopatías cervicales. No hay alteraciones analíticas específicas en el EM, pudiendo encontrarse leucocitosis, elevación de reactantes de fase aguda y de transaminasas. Si existe sintomatología respiratoria, una radiografía de tórax y una PCR para *M.pneumoniae* deberían realizarse Solo en el caso de dudas diagnósticas (con otros procesos ampollosos, urticaria, síndrome de Sweet o vasculitis) se realizará una biopsia que mostrará un infiltrado de linfocitos en la unión dermo-epidérmica junto con ligera necrosis de la epidermis, lo que lo suele permitir la diferenciación del espectro de lesiones del síndrome de Stevens-Johnson/Necrosis Epidérmica Tóxica donde la necrosis epidérmica es muy pronunciada.



TRATAMIENTO EN URGENCIAS

Las lesiones son autolimitadas y curan sin secuelas por lo que el objetivo del tratamiento es el alivio sintomático y la reducción de la duración de la sintomatología.

El uso sistemático de corticoides sistémicos, pese a su controversia en cuanto a las complicaciones infecciosas, está recomendado en pacientes con lesiones de intensidad moderada o grave a dosis de 0.5-1 mg/kg en pauta corta de 5-7 días. Para las lesiones orales los anestésicos y los corticoides tópicos proporcionaran alivio sintomático. En estos pacientes es fundamental evaluar si las lesiones orales impiden la alimentación per oris de cara a valorar ingreso.



Las lesiones de EM aparecen después de la infección por VHS, con una media de 7 días tras el brote, y por tanto no se recomienda el tratamiento antivirico en el momento agudo, sin embargo, la terapia supresora es efectiva para prevenir las recurrencias al disminuir los episodios de infección por VHS. En raras ocasiones el brote de VHS puede aparecer a la vez que el brote de EM o después, pudiendo iniciarse en ese momento tratamiento antivirico tras demostrar la infección con una muestra para PCR que mostrará el resultado en 24 horas.

PUNTO ALERTA

- El diagnóstico del EM es clínico y solo ante la duda con otros procesos deben realizarse exploraciones complementarias.
- El tratamiento es sintomático, con corticoides orales a dosis de 0.5mg/kg durante 5 días, utilizándose el Aciclovir solo para la prevención de futuros brotes y no de manera general en el tratamiento agudo.

REFERENCIAS

- Auquier-Dunant A et al: Correlations between clinical patterns and causes of erythema multiforme majus, Stevens-Johnson Syndrome and toxic epidermal necrolysis. Arch Dermatol **138**:1019, 2002
- Weston WL: Herpes-associated erythema multiforme. J Invest Dermatol **124**:xv, 2005

- Wetter DA, Davis MD: Recurrent erythema multiforme: Clinical characteristics, etiologic associations, and treatment in a series of 48 patients at Mayo Clinic, 2000 to 2007. J Am Acad Dermatol **62**:45, 2010

SÍNDROME DE STEVENS-JOHNSON Y NECROLISIS EPIDÉRMICA TÓXICA

Pablo Chicharro, Pedro Rodríguez-Jiménez, Ester Muñoz-Aceituno.

INTRODUCCIÓN

El Síndrome de Stevens-Johnson (SSJ) y la Necrolisis Epidérmica Tóxica (NET) son cuadros infrecuentes, pero que pueden tener una elevada mortalidad. Se diferencian clínicamente en el porcentaje de superficie corporal afectada, con un incremento proporcional de la mortalidad. Ambos son más frecuentes en mujeres y pacientes inmunocomprometidos. En la mayoría de los casos están desencadenados por un agente farmacológico, especialmente en la NET, siendo los más frecuentes: alopurinol, antibióticos, AINEs y anticonvulsivantes. El riesgo es máximo en la primera semana de tratamiento. Tras la exposición al fármaco, se desencadena una reacción de hipersensibilidad con la apoptosis masiva de queratinocitos que provoca la necrolisis epidérmica responsable del cuadro clínico.

Los síntomas iniciales suelen consistir en fiebre, sensación de cuerpo extraño ocular y odinofagia, que preceden de 1 a 3 días a la afectación cutánea. Las lesiones suelen iniciarse como máculas eritemato-violáceas, con tendencia a la coalescencia, afectando al tronco, con extensión progresiva cefálica y a región proximal de extremidades. Las palmas y plantas también pueden afectarse y hacerlo de forma temprana. Las lesiones progresan hacia máculas de coloración grisácea en horas o días, con formación paralela a la necrosis de ampollas flácidas, frágiles y con signo de Nikolsky positivo, otorgando un aspecto de piel escaldada. En la mayoría de los pacientes hay eritema y erosiones de mucosa orogenital y oculares, siendo la afectación de mucosas muy dolorosa. Además de la fiebre, entre las manifestaciones sistémicas se incluyen: tos, disnea, dolor abdominal, diarrea y adenopatías.



DIAGNÓSTICO

El diagnóstico de SSJ y NET es fundamentalmente clínico. Ante la aparición de lesiones cutáneas compatibles, afectación de mucosas y la introducción reciente de fármacos sospechosos, debemos establecer la sospecha clínica y no postponer el resto del abordaje diagnóstico-terapéutico. Según el porcentaje corporal afectado tendremos tres categorías: 1) Menos del 10%:

SJS, 2) 10-30%: Solapamiento SJS/NET, 3) Más del 30%: NET. Una mayor afectación implica un peor pronóstico y, por lo tanto, exige un abordaje más agresivo. En el estudio complementario inicial se debe incluir: hemograma (descartar citopenias), coagulación (coagulopatía de consumo), bioquímica (valoración de función renal, hidroelectrolitos, colestasis y citolisis). Si hay sintomatología respiratoria, se debe realizar una radiografía de tórax ante el riesgo de progresión a distrés respiratorio. El estudio histopatológico será de confirmación, mostrando necrosis de queratinocitos epidérmicos, con formación de ampollas subepidérmicas y con inmunofluorescencia negativa.



TRATAMIENTO EN URGENCIAS

El tratamiento de ambos cuadros, fundamentalmente de la NET, debe ser inmediato ante la sospecha diagnóstica y seguirá las mismas premisas que el de grandes quemados. En primer lugar y si conocemos el fármaco responsable, se procederá a su retirada. Si la superficie corporal afectada es mayor al 20%, se recomienda el manejo en una unidad de cuidados intensivos. Se debe realizar un adecuado aporte volémico, con corrección de las alteraciones hidroelectrolíticas. Se prestará especial atención al riesgo de sobreinfección bacteriana, aplicando antibióticos tópicos de forma profiláctica (mupirocina o ácido fusídico) e instaurando antibioterapia sistémica precozmente si hay datos de sobreinfección, previa toma de cultivos. En el cuidado tópico se pueden realizar lavados con soluciones de suero salino isotónico, aplicando posteriormente vaselina no perfumada, especialmente en zonas de presión. Se manipulará mínimamente al paciente y bajo medidas tan asépticas como sea posible. Puede ser necesaria la valoración especializada oftalmológica y el empleo de colirios antibióticos. Respecto a tratamientos específicos no existe ninguna evidencia establecida, con una alta controversia respecto al empleo de corticoides. Si se considera su empleo, se recomiendan pulsos cortos de 3 días con dexametasona (1,5mg/kg/día). El empleo de inmunoglobulinas intravenosas también puede frenar la progresión de la enfermedad (>2g/kg dosis total, repartida en 3-4 días).

ALERTA

- Debido a su elevada mortalidad, ésta es una auténtica emergencia dermatológica. No debemos retrasar el tratamiento y las primeras pruebas complementarias en un paciente que

presenta lesiones cutáneas compatibles, lesiones en mucosas u oculares, y un antecedente farmacológico reciente.

BIBLIOGRAFÍA

- Lerch M, Mainetti C, Terzioli Beretta-Piccoli B, Harr T. Current perspectives on Stevens-Johnson syndrome and toxic epidermal necrolysis. Clin Rev Allergy Immunol. 2018;54:147-176.
- Dodiuk-Gad RP, Chung WH, Valeyrie-Allanore L, Shear NH. Stevens-Johnson syndrome and toxic epidermal necrolysis: an update. A J Clin Dermatol. 2015;16:475-93.
- Downey A, Jackson C, Harun N, Cooper A. Toxic epidermal necrolysis: review of pathogenesis and management. J Am Acad Dermatol. 2012;66:995-1003.